

45 - 03-la dysphonie - Pr. ROCHDI

(0:00 - 0:22)

Aujourd'hui, on va traiter la dysphonie. C'est un symptôme fréquent en ORL qui est en rapport avec une atteinte au niveau du larynx. Alors, la dysphonie se définit par une altération du son produite par la mise en vibration des cordes vocales.

(0:23 - 1:00)

C'est précisément une atteinte au niveau des cordes vocales qui va entraîner une perte des caractéristiques normales de la voix concernant l'intensité de la voix, la hauteur et bien le thème. Alors, cette définition est très importante parce qu'elle va nous permettre de parler par la suite par des diagnostics différenciés. Il faut différencier la dysphonie par rapport aux autres atteintes qui ne sont pas en rapport avec une altération de la vibration des cordes vocales.

(1:02 - 1:22)

D'abord, on va faire un rappel anatomopysiologique des cordes vocales. Elles siègent au niveau du larynx et plus précisément au niveau du plan glottique. Le larynx est constitué de trois étages l'étage susglottique, l'étage glottique et l'étage subglottique.

(1:23 - 1:48)

L'étage glottique est constitué par les cordes vocales avec les entreprises vocales des cartilages arrêtés du nid. Au-dessus, il y a l'étage subglottique avec le ventre cul de la ligne ici avec les bandes ventriculaires et les vestibules arrangées vers l'eau. L'étage subglottique est constitué par un seul espace.

(1:51 - 2:29)

Un autre élément qui est important ici c'est l'articulation phyco-arrêtée qui se fait entre le cartilage arrêté et le cartilage fluide. C'est une articulation très dynamique sous la dépendance des muscles intrinsèques du larynx et qui va permettre l'ouverture et la fermeture des cordes vocales. L'innervation des muscles intrinsèques du larynx est sous la dépendance de deux nerfs, le nerf prédominant et le nerf récurrent.

(2:30 - 3:10)

Les deux sont des branches du nerf vague et le nerf laryngé inférieur ce qu'on appelle le nerf récurrent et le nerf laryngé supérieur. Le nerf laryngé inférieur va innover la majorité des muscles intrinsèques du larynx avec le crico-arrêté immédiat postrépeur, le crico-arrêté immédiat latéral, l'inter-arrêté immédiat, le thyro-arrêté immédiat. Le nerf laryngé supérieur, lui, il va innover le muscle crico-thyroïdien qui est un nerf tenseur des deux cordes vocales.

(3:11 - 3:55)

La production du son laryngé est sous la dépendance des vibrations présentes au niveau des cordes vocales. Lors de la phonation, les deux cordes vocales se mettent en abduction, donc il y a un contact entre les deux cordes vocales et l'air expiratoire, l'air qui est expiré par le poumon, cette pression expiratoire va augmenter jusqu'à ce qu'elle va séparer les deux cordes vocales et il y aura un passage de l'air dans un espace très réduit qui va entraîner une vibration du bord libre des deux cordes vocales. Cette vibration, ces ondulations de la muqueuse vont produire le son primaire sur le son laryngé.

(3:55 - 4:25)

Ce son laryngé va être modifié par les qualités de résonance et qui va définir à la fin la voix. La dysphonie est une modification du son qui est produit à ce niveau-là. Si on a une modification de cette physiologie pronatoire au niveau des cordes vocales, ça va entraîner une dysphonie.

(4:25 - 7:21)

C'est la définition de la dysphonie et c'est l'explication physiologique de la production du son laryngé. Quelle est la conduite à tenir devant un patient qui a une dysphonie ? D'abord, il faut commencer par l'interonaturale, c'est-à-dire une anamnèse pour rechercher certaines informations concernant la date de début, le mode, c'est-à-dire est-ce que c'est une installation progressive ou bien une dysphonie d'installation progressive. Il faut avoir une idée sur le terrain, rechercher la notion de tabagisme.

Tabagisme pour nous, c'est-à-dire le calcul du nombre de paquets années, est-ce qu'il y a un alcoolisme associé ? Avoir une idée sur la profession du patient puisque certaines professions comme par exemple les enseignants, les chanteurs, ils sont beaucoup aussi exposés du fait de l'utilisation prolongée de la voix et des cordes vocales exposées à présenter des modifications de la voix. Une chirurgie cervicale et plus précisément la chirurgie thérapeutique puisque la langue intérieure a des rapports intimes avec le nerf laryngé supérieur et surtout le nerf laryngé inférieur et de ce fait, une atteinte de ce nerf peut entraîner un problème de la mobilité des cordes vocales, d'être responsable ou dysphonie. Une chirurgie thoracique, pourquoi ? Parce que le nerf laryngé inférieur a un trajet intra-thoracique, c'est-à-dire exactement du côté gauche, surtout lors de la chirurgie de certaines malformations, exemple la persistance du canal artérielle par exemple, lors de cette chirurgie on peut avoir une atteinte du nerf laryngé inférieur à ce niveau-là.

Rechercher les circonstances d'apparition après une chirurgie, lors d'un traumatisme, après une intubation éventuellement, après une chirurgie, après une chirurgie générale avec intubation laryngo-fractiale, et avoir une idée sur l'évolution de la dysphonie, est-ce qu'elle est intermittente ou bien c'est une évolution progressive de la dysphonie jusqu'à ce que la dysphonie devient constante. Et bien sûr rechercher s'il y a d'autres signes associés par exemple, est-ce qu'il y a une dysphagie, est-ce qu'il y a une dysplasie, des auralgies, des auralgies

réflexes, puisque certaines atteintes au niveau du larynx peuvent se manifester par des aulgies réflexes, alors rechercher aussi des paresthésiques arrangées. Pour rechercher les caractères de la dysphonie, une voie roque, c'est-à-dire une voie qui est dure, ou bien une voie qui est voilée, couverte, une voie spastique, jusqu'à ce que parfois on peut avoir certains types de dysphonie se forment d'une aphonie complète.

(7:24 - 8:55)

Alors, le diagnostic positif de la dysphonie est l'unique. C'est une modification de la voie qui est produite par la vibration des courantes vocales. Il ne faut pas la comprendre avec une voie qui est saine lors de l'insuffisance respiratoire chronique, ne pas la comprendre avec une rhinolalie fermée, qui est une modification de la voie qui est en rapport avec l'intrusion nasale, et une rhinolalie ouverte, c'est-à-dire une modification de la voie en rapport avec une incompétence au niveau du voile du palais.

Cette incompétence insuffisante va entraîner des fuites de l'air à partir de l'orifarynx vers le cavogorge et ce qu'on appelle la rhinolalie ouverte. Une voie pharyngée, qui est en rapport en général avec un processus au niveau de l'orifarynx, tel un tumor de la base de la langue, un abcès égoïtype éventuellement, ou bien une désartrite, un trouble de langage en général, l'exemple type c'est la maladie de Parkinson. Bref, il faut essayer d'éliminer ces diagnostics différentiels pour ne retenir à la fin que des modifications qui sont en rapport avec une atteinte dans le mécanisme, une atteinte de la vibration des cordes vocales.

(8:57 - 9:30)

L'examen clinique commence par un examen cervical. Il faut inspecter et palper le cou, rechercher une cicatrice de thyroïdectomie, une cicatrice horizontale basse en rapport avec une chirurgie thyroïdienne, ou bien une incision, une cicatrice le long de la région du glucocardium thyroïdienne qui oriente vers une chirurgie de la région du glucocardium thyroïdienne. La palpation du cartilage laryngé et bien sûr la palpation de la glande thyroïde.

(9:30 - 10:00)

On recherche un maudit thyroïdien, un goût, une lésion thyroïdienne maligne qui peut entraîner une paralysie des cordes vocales par une atteinte d'une aire laryngée inférieure ou parfois par une infiltration du larynx. L'examen du larynx se fait par la laryngoscopie indirecte. On va la voir sur la diapo suivante ou bien par la nasophibroscope.

(10:01 - 27:55)

La nasophibroscope et la laryngoscopie indirectes sont très importants puisqu'ils vont nous permettre d'explorer la morphologie du larynx et en même temps d'apprécier la dynamique du larynx c'est-à-dire la mobilité des cordes vocales et du cartilage avec elle-même. On complètera par un examen neurologique surtout des pertes crâniennes et un examen pleuropulmonaire recherché des signes curiants d'une atteinte pulmonaire une notion de chirurgie thoracique ou

bien par exemple une insuffisance respiratoire chronique qui peut nous orienter vers une atteinte qui n'est pas en rapport avec un problème des cordes vocales mais plutôt une insuffisance respiratoire chronique et qui va donner dans ce cas-là une voix faible. Alors ici sur la diapo, on voit l'examen par la laryngoscopie indirecte. Alors comment il se fait ? Il faut avoir une lumière frontale avec la main gauche on demande au patient d'abord de tirer la langue il la prend entre le pouce et l'index avec une compresse en tirant sur la langue on élargit leur pharynx et avec un miroir qui est déjà chauffé pour ne pas avoir de la buée dessus un miroir qui est introduit derrière la base de langue un peu derrière le voile du palais qui est incliné vers le bas et qui va nous donner une image inversée des cordes vocales on verra ici par exemple l'épiglotte l'étage cislottique les deux arrêts mi-gauche et droit la commissure postérieure la commissure antérieure aussi et les cordes vocales sous forme de cordon blanchâtre en demandant au patient de prononcer la lettre I ça va entraîner une adduction une fermeture glottique à partir de là on pourra apprécier la mobilité des cordes vocales alors on va dire qu'elle permet d'explorer la morphologie de la pharynx on verra la muqueuse, est-ce qu'il y a une tumeur est-ce qu'il y a une inflammation de la muqueuse et en même temps vérifier la mobilité des cordes vocales pour vérifier si la mobilité est correcte est-ce que la diction se fait de façon symétrique ou bien il y a une paralysie une immobilité d'un arrêt mi-gauche et de la corde vocale correspondante la nasophibroscope c'est un examen qui se fait à l'aide d'un fibroscope qui est introduit par la force nasale qui passe au niveau, à travers les quad au niveau du rhinopharynx qui va descendre derrière le voile du palais et à partir de là on pourra explorer toute la muqueuse du rhinopharynx, de l'europharynx et en même temps regarder d'en haut le larynx, on va explorer bien sûr la morphologie, c'est-à-dire toute la muqueuse du larynx avec ses différents étages et en même temps en demandant au patient, comme dans la laryngoscopie indirecte, de prononcer la lettre I on pourra voir la fermeture glottique est-ce que la fermeture est symétrique est-ce qu'il y a une paralysie ou une paralysie d'une corde vocale, c'est un examen qui est très facile qui peut être fait sous anesthésie locale ou parfois sans anesthésie locale il est de plus en plus utilisé et beaucoup plus utilisé que dans la laryngoscopie indirecte puisque ici dans la nasophibroscope on a moins de réflexes nauséux on peut explorer et répéter l'examen plusieurs fois, c'est plus facile à faire par contre, la laryngoscopie indirecte est de moins en moins utilisée et chez certaines personnes le réflexe nauséux est très important et le médecin ne pourra pas compléter l'examen vu que le patient ne tolère pas cet examen dans certains cas. Alors quels sont les autres examens qu'on peut demander pour explorer une dysphorie d'abord il y a le scanner du larynx qui va nous permettre d'explorer surtout le cartilage du larynx, c'est une imagerie qui est demandée surtout dans les cancers du larynx ou bien dans un contexte de traumatisme du larynx, donc ça va nous permettre d'explorer le squelette laryngé, c'est-à-dire le cartilage le cartilage liquide et le cartilage aréthroïde et en même temps dans la pathologie tumorale explorer l'extension tumorale rechercher les lésions en général soumiquieuses, parfois qui ne sont pas visibles à la laryngoscopie et en même temps rechercher l'extension tumorale qui peut se faire à travers les trois étages du larynx ou parfois même en dehors du larynx le deuxième examen paraclinique qui est fréquemment utilisé, c'est la laryngoscopie directe en suspension alors c'est quoi la laryngoscopie directe en suspension c'est un examen qui est fait d'abord sous anesthésie

générale le patient est anesthésié avec ou sans ventilation et le médecin va mettre en place ce qu'on appelle un laryngoscope avec une lumière parfois aidé par le microscope ou bien par un endoscope et on pourra explorer toute la muqueuse du larynx et même en dehors du larynx c'est à dire au niveau de l'hypopharynx, voire au niveau de l'œsophage donc on fera une exploration complète de toute la muqueuse on pourra même explorer l'étage sous glottis qui est parfois difficile à visualiser à la masophiloscopie et on essayera de voir est-ce qu'il y a une tumeur présente vérifier son extension et qui va nous permettre en même temps de faire des biopsies pour des examens anatomopathologiques ou même bactériologiques alors l'inconvénient de la laryngoscopie directe c'est qu'il ne nous permet pas d'explorer la mobilité des portes vocales puisque l'examen est fait sous anesthésie générale donc la mobilité, la dynamique du larynx c'est surtout dans la laryngoscopie indirecte ou bien à la masophiloscopie l'étude anatomopathologique va nous permettre d'examiner et de rechercher surtout des tumeurs la nature de certains tumeurs parce qu'ils sont bénis ou bien malins tout en sachant qu'en général c'est le carcinome qui est la tumeur la plus fréquente au niveau du larynx dans certains cas on peut être amené à demander ce qu'on appelle une électromyographie laryngée devant des paralysies du larynx et qui va avoir un double objectif d'abord un diagnostic pour voir est-ce qu'on est devant une atteinte périphérique parfois centrale et deux pour pouvoir suivre l'évolution de certaines pathologies neurologiques du larynx alors là c'est un schéma qui nous montre le patient et du laryngoscope au cours d'une laryngoscopie directe vous voyez le patient, il est en équilibre dorsal dans une position allongée le laryngoscope est introduit par voie buccale centré sur le larynx le patient est intubé et le médecin va pouvoir regarder à travers le laryngoscope soit à l'œil nu, soit avec une optique ou bien en général avec un microscope et voilà l'image que ça donne on a le larynx avec ses trois étages l'upiglote ici, l'étage susglottique les arithmiides, les cordes vocales et au-dessus des cordes vocales on a l'étage subglottique et on peut même explorer le reste ici au niveau de la base de l'ongle avec les valébrés ici et à ce niveau-là les sinus périformes avec le reste de l'hypopharynx alors quelles sont les étiologies des dysphonies d'abord on les divise en deux parties les dysphonies organiques c'est-à-dire en rapport avec les lésions organiques et les dysphonies dysfonctionnelles avec les cordes vocales normales à l'examen clinique alors dysphonie organique ça veut dire qu'on a objectivé une lésion organique au niveau des cordes vocales d'abord il y a les lésions tumorales des cordes vocales qu'elles soient bénignes ou malignes bénignes en général on peut avoir des tumeurs dignes de toute nature ça c'est un exemple de kyste au niveau de la corde vocale gauche vous voyez ici la corde vocale droite la corde vocale gauche, la commissure antérieure la commissure postérieure ça c'est dépression, c'est l'entreprise organique et vous voyez ici cette lésion blanchâtre soumiseuse qui est un kyste de la corde vocale gauche et ici c'est un autre exemple mais de tumeur maligne on a ici une tumeur bourgeonnante de la corde vocale droite de sa moitié antérieure même chose ici c'est une tumeur maligne bourgeonnante qui siège au niveau de la corde vocale gauche ou au niveau de la commissure antérieure donc cet aspect de tumeur saignante facilement au contact c'est un tumeur qui est ulcéré qui est bourgeonnante surtout chez une personne qui est tabagique le tabac c'est un facteur important c'est le troisième facteur incriminé dans la genèse des cancers du larynx donc ce genre de tumeur ulcéré bourgeonnante, friable, saignant au

contact c'est en faveur de la malignité c'est pour cela qu'on dit que devant toute dysphonie chronique chez un patient surtout tabagique il faudra absolument faire une nasofibroskopie pour éliminer une pathologie tumorale maligne pour donner au patient le maximum de chance d'être guéri de cette infection et en conservant en même temps son larynx inflammatoire et infectieux par exemple on est devant une laryngite aiguë qui peut être d'origine bactérienne ou virale là vous avez un larynx qui paraît inflammatoire surtout au niveau de l'étage soglotique et glotique on voit même un rafraîchissement de l'étage glotique ces laryngites aiguës vont être responsables de dysphonie et parfois même de dysphonie chez l'enfant les laryngites chroniques en général peuvent être d'origine infectieuse par exemple celle dans la papillomatose laryngée qui est en rapport avec une infection au virus human papillomavirus qui est le virus HPV la tuberculose ou bien la syphilis le tabac lui est responsable de laryngites d'origine inflammatoire c'est l'exemple ici une laryngite blanche l'irritation chronique qui est entraînée par l'expédiation au tabac on peut être responsable de modifications locales avec une muqueuse qui devient épaisse blanchâtre et ces lésions parfois peuvent entraîner une dégénérescence maligne et on verra l'apparition d'un cancer à ce niveau là donc ce genre de lésions de laryngite chronique blanchâtre nécessite une surveillance à long terme pour guetter et rechercher le passage à la malignité troisième étude c'est de paralyser la laryngite puisque on a dit que le larynx énervé par c'est un larynx qui est mobile les muscles intrinsèques sont énervés donc une paralysie laryngée surtout unilatérale va être responsable d'une paralysie des cordes locales soit après une chirurgie thérapeutique soit après une chirurgie thoracique ou parfois même après une chirurgie de la base du crâne les lésions traumatiques sont de deux types soit un traumatisme au cours d'une anesthésie générale avec intubation on peut avoir une lésion directe de la muqueuse voire parfois une fixation de la rétinoïde ou bien un traumatisme externe du larynx avec parfois une fracture du squelette cartilagineux du larynx qui va entraîner une dysphonie voire parfois une dysmère les malformations congénitales dysphonies et l'exemple type ici c'est les palmures laryngées donc là vous voyez deux cordes locales ça c'est la commissure antérieure et on voit que les deux cordes locales sont accolées au niveau de la partie antérieure chose qui n'est pas normale alors cet aspect là ça rappelle les palmures laryngées et qui vont être responsables d'une dysphonie chronique depuis la naissance constante, non évolutive et qui va nécessiter un traitement chirurgical les laryngocèles qui sont des formations aériennes qui naissent au niveau du ventricule de Morgagnie, au niveau du sacculus laryngé qui vont être plus ou moins importantes en fonction de leur volume et qui peuvent gêner la vibration des cordes locales dans la deuxième catégorie dans les histiologies des dysphonies c'est la dysphonie dysfonctionnelle dysphonie dysfonctionnelle c'est une dysphonie chronique et dans l'examen laryngé est normal c'est à dire que lorsqu'on va faire la laryngoscopie indirecte, la nasopharyngoscopie voire même une laryngoscopie directe, on va avoir souvent des cordes locales qui sont normales mais ces dysphonies dysfonctionnelles lorsqu'elles ne sont pas traitées vont être responsables de l'apparition de lésions organiques par exemple les nodules au niveau des cordes locales sont dus à une dysphonie dysfonctionnelle c'est une dysphonie dysfonctionnelle qui peut avoir un rapport avec un surmenage vocal quelqu'un qui utilise trop sa voix ou bien un malmenage, quelqu'un qui utilise mal sa voix ou bien un forçage vocal qui va associer ces différentes

situations donc ce surmenage, malmenage ou forçage vocal à la langue va ancrer l'apparition d'une dysphomie chronique et à la langue va être responsable de l'apparition de certaines lésions organiques qui sont témoins de la chronicité du phénomène et l'exemple type dans ce cas là c'est l'apparition de modules au niveau des cordes locales et le traitement dans ce cas là va être basé essentiellement sur la rééducation orthophonique qui va soulager le patient lui apprendre à respirer à utiliser sa voix de façon correcte et adéquate alors pour conclure devant toute dysphomie prenante sur un patient tabagique on doit évoquer en premier lieu une tumeur du larynx le tabac premier facteur des cancers du larynx et du poumon donc il faut absolument éliminer devant cette situation une tumeur maligne du larynx le bilan initial repose sur l'examen du corps vocal en consultation soit avec un miroir c'est à dire une laryngoscopie indirecte ou bien une nasopharyngoscopie alors s'il existe une lésion suspecte dans ce cas là une laryngoscopie directe en suspension avec le diopside s'impose